EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
INTERVENCIÓN – ATENCIÓN DE LA SALUD MATERNO INFANTIL

Elemento	Descripción
Problema / Necesidad de Salud	La Organización Panamericana de la Salud señala que a pesar del progreso alcanzado en materia de salud materno infantil en los países de América Latina y el Caribe, las diferencias en la cobertura y los resultados en salud en determinados grupos de población siguen siendo generalizadas, dejando en evidencia las desigualdades que se enfrentan en este tema (Sanhueza, y otros, 2022, pág. 46). Tal hallazgo, se ratifica con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual reconoce que durante el 2020 la razón de mortalidad materna en países de bajos ingresos fue de 430 muertes maternas por 100 000 nacidos vivos, frente a 12 por 100 000 nacidos vivos en los países de ingresos altos (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). Asimismo, el Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad en la Niñez, añade que pese a los avances en la reducción de la tasa mortinatalidad y la mortalidad de menores de cinco años, durante 2021, murieron cinco millones de niños antes de cumplir cinco años, y 1,9 millones de bebés nacieron muertos; muertes que podrían haberse evitado si las madres, los recién nacidos, los adolescentes y los niños tuvieran un acceso equitativo a una atención sanitaria de alta calidad (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2023). Ante el panorama expuesto, los sistemas de salud han desarrollado intervenciones costo efectivas como la detección y el abordaje oportuno de patología durante el embarazo que permiten evitar más del 90 % de las muertes maternas y las complicaciones obstétricas graves (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012, pág. 8); no obstante, un grupo de mujeres y niños aún se enfrentan a barreras económicas, geográficas y sociales, que les impiden el acceso a servicios de calidad, lo que hace que la morbimortalidad materno infantil se mantenga como un problema de salud pública. En Costa Rica, el comportamiento de la razón de mortalidad materna es fluctuante, registrándose para 2022 la razón más baja en los últimos diez años (1,5 por 10 000 mil nacidos vivos); sin embargo, a lo interno de las provincias, Puntarenas alcanzó la mayor razón de mortalidad del país durante 2022, con un 3,36 (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2022, pág. 11). Además, la tasa de mortalidad infantil (TMI) registrada a diciembre de 2022, de 9,58 por 1 000 nacimientos, es la más alta en los últimos cinco años y aumentó 11,1 % respecto a la tasa registrada para 2021 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC], 2023). Por otra parte, según los resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud (EPPS) 2022, en la institución se documentan coberturas de atención en salud materno infantil mayores al 80 %; sin embargo, a lo interno, la falta de acceso, el acceso tardío, así como la detección y el manejo no oportuno todavía afectan a unidades que en su mayoría se caracterizan por atender en sus centros a grupos de población que enfrentan, en mayor grado que otras, barreras económicas, geográficas, sociales y étnicas. Además, se añaden aspectos administrativos, como la distribución geográfica de los puestos de visita periódica y la capacidad instalada de los servicios. En general, condiciones como la fluctuación en la razón de mortalidad materna y el deterioro de la tasa de mortalidad infantil, como indicadores de inequidad y desigualdad,

	aunado a los resultados institucionales en acceso a los servicios y detección de patología, hacen que la salud materno infantil en Costa Rica se mantenga como un problema de interés en salud pública que amerita de intervenciones claves orientadas a fortalecer los programas de cobertura de atención, acceso temprano, detección y manejo de las enfermedades que inciden en la morbimortalidad materno infantil.
Evidencia	**Beneficios de la intervención por intervención y/o dimensión** Intervenciones en los sistemas de salud para mejorar la utilización y calidad de la atención prenatal: para reducir la mortalidad perinatal y mejorar la experiencia asistencial de las mujeres se recomiendan modelos de atención prenatal con un mínimo de ocho contactos. *Tipo de recomendación: Recomendada por OMS* (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2018, pág. 108). El U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) encontró evidencia convincente de que la detección temprana universal para la infección de sífilis en embarazadas reduce la incidencia de la sífilis congénita y los resultados adversos del embarazo asociados con infección materna. *Tipo de Recomendación A* (Curry, Krist, Owens, & Barry, 2018, pág. 913). El USPSTF también encontró pruebas convincentes que la identificación y el tratamiento de las embarazadas que viven con la infección por el VIH es de gran beneficio en la reducción de la tasa de transmisión de madre a hijo. La magnitud global del beneficio de la detección de la infección por el VIH en adolescentes, adultos y mujeres embarazadas es sustancial. *Tipo de Recomendación A* (Owens, 2019, pág. E2). El diagnóstico temprano de diabetes manifiesta no detectada previamente en una embarazada puede permitir la instauración rápida de una terapia para mitigar estos riesgos (Blumeer, y otros, 2013, pág. 4229). Es recomendable realizar glucosa plasmática de ayuno en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas a toda persona embarazada, para una detección temprana de mujeres con DM tipo 2 no diagnosticadas antes del embarazo. *Tipo de Nivel/grado Recomendación A NICE GPC* (Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], 2017, pág. 28). Evaluación de la evidencia el USPSTF concluye con certeza moderada que existe un beneficio neto moderado de la detección de diabetes gestacional a las 24 semanas de gestación o después para mejorar los resultados maternos y fetales. USPSTF recomienda la detección de diabetes gestacional en embarazadas asintomáticas a partir de las 24 semanas de gestación. *Tipo de Recomendación B* (Davidson, Barry, Mangione, & Cabana, 2021, pág. 531). Las mediciones de la presión arterial son importantes para identificar y tratar con eficacia una condición potencialmente impredecible y fatal, por lo que la USPSTF recomienda la detección de preeclampsia en mujeres embarazadas con mediciones de presión arterial durante el embarazo. *Tipo de Recomendación B* (Bibbins, Grossman, Curry, Barry, & Davidson, 2017, pág. 1662) Se encuentra que al menos una dosis de penicilina benzatínica IM aplicada 30 o más días antes del parto previene hasta en un 97% de los casos la infección en el feto, mortalidad y parto pretérmino. Esto supone un beneficio mayor al presentado con la no aplicación oportuna del tratamiento (casos de sífilis congénita, mortalidad perinatal). Es muy bajo el riesgo de presentar efectos adversos serios derivados de la administración

	de penicilina benzatínica, por lo tanto, se considera que es un tratamiento seguro que sumado a la efectividad comprobada en otros estudios apoya su administración en gestantes. El panel de expertos recomienda la aplicación inmediata de la penicilina. *Tipo de Recomendación fuerte a favor / Calidad de la evidencia: muy baja* (Ministerio de Salud y Protección Social y Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], 2014, pág. 28).
Consideraciones de Implementación	Barreras: Falta de capacitación del personal a cargo para la atención y seguimiento de los casos, así como para el uso y mantenimiento de los equipos: esfingomanómetros y glucómetros. Concentraciones de pobreza y/o riqueza. Acceso a servicios privados por condición laboral o económica. Alta dispersión geográfica y migración interna y externa. Población vulnerable: indígenas y adolescentes. Aseguramiento limitado por condición legal, laboral o económica. Capacidad instalada de los laboratorios clínicos para suplir las necesidades de la población (sean cupos, horarios, equipo, infraestructura o personal, reactivos). Estrategias: Brindar educación continua del personal a cargo de la atención y de la calidad y funcionabilidad de los equipos a través de la vigilancia y el mantenimiento por parte de los encargados o responsables. Intensificar los procesos de divulgación y educación sobre las políticas públicas de salud en el marco del estado migratorio o condición legal en el país y aseguramiento, además de otras relacionadas con las necesidades particulares de los grupos vulnerables como son las adolescentes, las personas indígenas y aquellas en estado de pobreza. Incorporar en sus planes y programas acciones destinadas a la organización y la estructura de los servicios, con el propósito de solventar las limitaciones asociadas a horarios de atención, frecuencias de las consultas en los puestos de visita periódica y la oferta de servicios de laboratorio clínico en cada área, estableciendo un sistema efectivo para la transferencia precisa y oportuna de los resultados de la prueba a los registros médicos.
Normativa Técnica	• Ley N° 9824. Reforma del artículo 12 de la ley 5395 Ley general de salud, de 30 de octubre de 1973, para proteger a la mujer embarazada, antes, durante y después del parto. • Ley N° 10081. Derechos de la mujer durante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido. • Protocolo Clínico de Atención Integral al embarazo, parto y posparto en la Red de Servicios de Salud, CÓDIGO.PAC.GM.DDSS. AAIP.260121 versión 01 Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud Área de Atención Integral a las Personas Programa de Normalización de Atención a la Mujer 2022 (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2022). • Lineamiento técnico LT.GM.DDSS.040123. Detección, abordaje y seguimiento de niños y niñas con sífilis congénita (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2023). • Modelo de atención calificada en el embarazo, parto, posparto: centrado en la mujer, la familia gestante, la gestión humanizada y la pertinencia cultural en las maternidades de la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2017). • Guía para la atención de la persona con diabetes mellitus tipo 2. Área de Atención Integral a las Personas-Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud.3ra edición. San José - Costa Rica (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2020).

Costo / Efectividad	Un estudio realizado en Sudáfrica examinó los datos disponibles sobre mortinatos específicos de este país y evalúo el impacto y la rentabilidad de 13 intervenciones reconocidas para prevenir los mortinatos y la mortalidad materna y neonatal. Concluyendo que las intervenciones fueron altamente rentables y la mejora de la cobertura de 13 intervenciones que ya se recomiendan, podría tener un impacto significativo en las tasas de mortinatalidad y mortalidad materna y neonatal. (Michalow, y otros, 2015, pág. 1). Una serie de estudios de la relación costo-efectividad efectuados en 2013, 2014 y 2015 pusieron de manifiesto que en situaciones de prevalencia elevada se ahorraban costos y que el costo por año de vida ajustado en función de la discapacidad (AVAD) se situaba dentro de lo que la OMS considera estándar en entornos con baja prevalencia. Concluyendo en términos generales, que el tamizaje universal es preferible a la ausencia de tamizaje porque trae aparejada una probable y sustancial reducción de la sífilis congénita y de resultados adversos graves del embarazo independientemente del nivel de prevalencia de la sífilis. (Organización Mundial de la Salud [OMS] y Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2019, pág. 18). Este estudio considera el impacto potencial y el costo de aumentar las intervenciones comprobadas para reducir las muertes de madres, recién nacidos y niños, así como los mortinatos. Considera que el número anual de muertes maternas e infantiles a nivel mundial ha disminuido notablemente en los últimos 25 años; sin embargo, en muchos países la tasa de reducción ha sido demasiado lenta. Concluyendo que para acelerar este progreso se propone ampliar los paquetes integrados de intervenciones esenciales en todo el continuo del cuidado de la salud reproductiva, materna, del recién nacido y el niño (SMRN). Sustentados en que estas intervenciones son altamente costo-efectivas y resultan en una relación costo-beneficio de 7-11 al 2035 (valor actual neto en dólares estadounidenses de los beneficios a los costos). Lo que conllevaría a evitar 149 000 muertes maternas; 849 000 muertes prenatales; 1 498 000 muertes neonatales; y 1 515 000 muertes infantiles, representando el impacto con las tasas actuales de embarazo, nacimiento y mortalidad (Black, Walker, Laxminarayan, & Temmerman, 2018)
Objetivo (s) de la Evaluación	Valorar el acceso, la detección y manejo oportuno de la población materno infantil, con el fin de identificar las brechas en la equidad a los servicios y aportar elementos para la formulación de estrategias para la prevención de complicaciones en la madre y el recién nacido.
Pregunta (s) de Evaluación	¿Cuáles son las brechas y las probables determinantes en los resultados de la cobertura de atención temprana en la atención de salud materno infantil entre las unidades que conforman el primer nivel de atención? ¿Cuáles son los logros de la oportunidad en el acceso y detección oportuna en el embarazo con relación al paquete básico de intervenciones de las embarazadas? ¿Cuáles son las deficiencias en la cadena acontecimientos en la atención de las embarazadas seropositivas para sífilis?

Indicadores asociados a la intervención	02-01-1.0 Cobertura de atención temprana de menores de un año 02-02-1.0 Cobertura de atención temprana de mujeres en periodo posnatal 02-03-1.0 Cobertura de atención temprana de embarazadas 02-04-2.1 Porcentaje de embarazadas a quienes se les completa el paquete básico de intervenciones según edad gestacional. 02-05-1.0 Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado
Anexos	**Consenso con equipo técnico** Minuta de reunión con Programa de Normalización de Atención a la Mujer y Comisión Gerencial de Maternidades. Participantes: Dra. Carla Gríos Dávila, Dr. Jorge Arturo Mora Sandí, Dra. Alina del Carmen Gutiérrez Rodríguez, Dra. María Griselda Ugalde Salazar. (02 marzo 2023) Acuerdos: se avala los indicadores: • Porcentaje de embarazadas a quienes se les realiza un paquete básico de intervenciones según edad gestacional. • Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado. Minuta de reunión con Área de Atención Integral a las Personas, Programa de normalización de la atención de las infecciones de transmisión sexual. (15 de agosto 2023). Participantes: Dra. Gloria Terwes Posada y Dra. Silvia Vanesa Briceño Méndez Acuerdos: se avala los indicadores: • Porcentaje de embarazadas a quienes se les realiza un paquete básico de intervenciones según edad gestacional. • Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado. Minuta de reunión con Área de Atención Integral a las Personas, Programa de normalización de la atención de las infecciones de transmisión sexual. (25 de agosto 2023). Participantes: Dra. Gloria Terwes Posada, Dra. Silvia Vanesa Briceño Méndez y enlaces de red: Yendri Pamela Sáenz Madrigal, Yorleny Morales Alfaro, Melvin Anchía Villalobos, Nidia Morera Murillo, Yihonory Patricia Martínez Guillén, Luis Diego Mora Madrigal, Clary Yessenia Delgado Delgado, Tania Medina Alfaro, Juliana Monge Arguello, Heraldo Monge Duarte, Laura Sánchez Ortiz Acuerdos: se avala los indicadores: • Porcentaje de embarazadas a quienes se les realiza un paquete básico de intervenciones según edad gestacional. • Porcentaje de embarazadas seropositivas para sífilis que reciben tratamiento oportuno y adecuado.
Referencias Bibliográficas	Bibbins, K., Grossman, D., Curry, S., Barry, M., & Davidson, K. (25 de abril de 2017). Screening for Preeclampsia US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA, 317*(16), 1661-1667. doi:10.1001/jama.2017.3439 Black, R., Walker, N., Laxminarayan, R., & Temmerman, M. (2018). Salud reproductiva, materna, del recién nacido y del niño: mensajes clave de este volumen. En D. Jamison, H. Nugent, S. Gelband, P. Horton, & R. Laxminarayan, Prioridades para el control de enfermedades: Compendio de la tercera edición. (pág. 89). Washintong: Banco Mundial. Obtenido de

https://documents1.worldbank.org/curated/en/502171618819290636/pdf/Prioridades-para-el-control-de-enfermedades-Compendio-de-la-3a-edicion.pdf

Blumeer, I., Hadar, E., Hadden, D., Jovanovic, L., Mestan, J., Hassan, M., & Yogev, Y. (1 de noviembre de 2013). Diabetes and Pregnancy: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 98*(11), 4227–4249. doi:10.1210/jc.2013-2465

Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2017). Modelo de atención calificada en el embarazo, parto, posparto: centrado en la mujer, la familia gestante, la gestión humanizada y la pertinencia cultural en las maternidades de la Caja Costarricense de Seguro Social. Obtenido de https://www.mamasol.com/wp-content/uploads/2019/12/Modelo-ATENCION-CALIFICADA-EN-EL-EMBARAZO-PARTO-POSPARTO-ULTIMO.pdf

Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2020). Guía para la atención de la persona con diabetes mellitus tipo 2. Obtenido de https://repositorio.binasss.sa.cr/repositorio/bitstream/handle/20.500.11764/3487/Gu%C3%ADaDM.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2022). Protocolo Clínico de Atención Integral al embarazo, parto y posparto en la Red de Servicios de Salud. Obtenido de https://www.cendeisss.sa.cr/wp/wp-content/uploads/2023/02/Protocolo-de-Atencion-Clinica-integral-al-embarazo-parto-y-postparto-2.pdf

Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS]. (2023). Lineamiento técnico LT.GM.DDSS.040123 Detección, abordaje y seguimiento de los niños y niñas con sífilis congénita.

Curry, S., Krist, A., Owens, D., & Barry, M. (setiembre de 2018). Screening for Syphilis Infection in Pregnant Women US Preventive Services Task Force Reaffirmation Recommendation Statement. *JAMA, 320*(9), 918-948. doi:10.1001/jama.2018.11785

Davidson, K., Barry, M., Mangione, C., & Cabana, M. (10 de agosto de 2021). Screening for Gestational Diabetes US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*, 539-577. doi:10.1001/jama.2021.11922

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF]. (18 de julio de 2023). *Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia*. Obtenido de Un informe de las Naciones Unidas revela que un niño o un joven murió cada 4.1 segundos en 2021: https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/un-informe-de-las-naciones-unidas-revela-que-un-ni%C3%B1o-o-un-joven-muri%C3%B3-cada-44#:~:text=La%20tasa%20de%20mortalidad%20de,se%20redujo%20en%20un%2035%25.

Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS]. (2017). *Control prenatal con atención centrada en la paciente.Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. Actualización 2017.* México: IMSS. Obtenido de https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/028GER.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC]. (2022). *Mortalidad Materna y su evolución reciente 2021.* San José, Costa Rica: INEC. Obtenido de https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-01/repoblacdefEV_2021A_mortalidad%20materna%20y%20su%20evoluci%C3%B3n%20reciente.pdf

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC]. (2023). *Tasa de mortalidad infantil interanual abril 2023.* San José, Costa Rica: INEC. Obtenido de https://admin.inec.cr/sites/default/files/2023-06/RePoblacEv-TMII04-2023.pdf

Michalow, J., Schola, L., McGee, S., Tugendhaft, A., Pattinson, R., Kerberth, K., & Hofman, K. (2015). Triple return on investment: the cost and impact of 13 interventions that could prevent stillbirths and save the lives of mothers and babies in South Africa. *BMC Pregnancy & Childbirth, 15*(39). doi:10.1186/s12884-015-0456-9

Ministerio de Salud de Colombia y Protección Social y Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA]. (2014). *Guía de práctica clínica (GPC) basada en la evidencia para la atención de la sífilis gestacional y congénita Sistema General de Seguridad Social en Salud.* Bogotá Colombia: Ministerio de Salud y Protección Social. Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/gpc-guia-corta-sifilis.pdf

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2012). *Organización Mundial de la Salud Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproducción.* Montevideo, Uruguay: OMS. Obtenido de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49332/CLAP1593.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (18 de julio de 2023). *Organización Mundial de la Salud*. Obtenido de Mortalidad Materna: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

Organización Mundial de la Salud [OMS] y Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2019). *Guía de la OMS sobre detección y tratamiento de la sífilis en embarazadas.* Washington: OPS. Obtenido de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51791/9789275321744_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2018). *Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo.* Washington DC: OPS. Obtenido de https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49550/9789275320334_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Owens, D. (11 de junio de 2019). Screening for HIV Infection US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *JAMA*. doi:10.1001/jama.2019.6587

Sanhueza, A., Carvajal, L., Cueva, D., Camacho, A., Berroterán, M., Horowitz, D., . . . Mujica, O. (2022). La iniciativa Todas las mujeres Todos los niños brinda apoyo a los países de América Latina y el Caribe para reduir las desigualdades sociales en salud. *Revista Panam Salud Pública*, 46. doi:https://doi.org/10.26633/RPSP.2022.201